ATP | MÓDULO E3M40 | FUNCIONALIDADE III, COGNIÇÃO E HUMOR

Handout docente

Notas de condução, detalhe operacional e referências

Prof. João Frederico Musial

Medicina | Campo Real | 2026

ATP ”Risco de Suicídio: avaliação e conduta”. Módulo E3M40, Funcionalidade III, Cognição e Humor. Medicina, Centro Universitário Campo Real, 2026. Turma de 62 alunos, docente conduzindo sozinho. Sessão das 13h30 às 17h00.

Este documento reúne o que saiu da tela: as notas de condução, o detalhe operacional que a preleção só menciona e as referências. A regra de composição da aula foi que o desenvolvimento vai para esta nota, e não para o slide.

Cronômetro e cronograma

O Tempo 2 inteiro roda com cronômetro projetado. Sem ele, as defesas comem a plenária, e a plenária é onde o aprendizado acontece.

- 13h30 às 14h55, preleção, 85 minutos, 40 frames. São cerca de dois minutos por frame, o que só fecha se os frames de tabela e de diagrama forem falados e não lidos.
- 14h55 às 15h05, explicação da atividade, 2 frames.
- 15h05 às 15h20, intervalo de 15 minutos.
- 15h20 às 16h00, trabalho dos seis grupos, 40 minutos.
- 16h00 às 16h30, defesas, 4 minutos por grupo, transições cronometradas.
- 16h30 às 16h55, plenária comparativa por pares.
- 16h55 às 17h00, fechamento.

Marcos internos da preleção, para não perder o passo: às 13h50 você deve estar entrando na parte 2; às 14h15, na parte 3; às 14h35, na parte 4; às 14h50, na parte 6.

Como o deck se orienta sozinho

A turma tem 62 alunos e nem todos estarão perto da tela. Duas marcas resolvem isso sem que você precise dizer onde está.

A primeira é a cor, que já era o mapa do projeto: azul é avaliação e entrevista, âmbar é mudança recente e janela de vigilância, vermelho queimado é ação imediata e decisão de ambiente, verde é suporte e continuidade, grafite é norma e registro, roxo é farmacologia. A segunda é o ícone, que acompanha a

cor sempre no mesmo par e nunca aparece sozinho. Um aluno que olhe a tela de longe sabe se aquilo é pergunta, alerta, conduta, proteção, lei ou fármaco antes de ler.

Se em algum momento você precisar dizer à turma o que a cor significa, o frame da matriz, na parte 3, é o lugar: ali as cinco caixas aparecem juntas, uma de cada família, e o mapa se explica sozinho.

Notas de condução, parte por parte

Parte 0, abertura

O aviso de conteúdo é dito de pé, olhando para a turma, e não lido. A frase que importa é que sair não precisa de justificativa e não será registrado. Diga o CVV 188 em voz alta uma vez. Não pergunte se alguém já passou por isso, não peça relato pessoal e não abra roda de experiência: a aula é sobre a conduta do médico, e a exposição de história pessoal em turma de 62 não é manejável por um docente sozinho.

Se algum aluno sair, não o procure na sequência da aula. Procure no intervalo, sem plateia.

Parte 1, o que estamos tentando entender

O único ponto que precisa ficar é que os fenômenos se relacionam nos dois sentidos. Se alguém desenhar a pirâmide na prova, a aula falhou aqui.

No frame da tendência, diga por que só há dois pontos: o boletim publica a série em figura, sem tabela ano a ano, e reconstruir números a partir de um gráfico seria inventar dado. Essa observação vale como lição de método e custa quinze segundos.

No frame das faixas etárias, a pergunta a fazer à turma é: em qual dessas faixas vocês perguntam sobre morte hoje, no estágio? A resposta costuma ser nenhuma, e o frame seguinte responde por quê isso importa.

Parte 2, como perguntar

Peça que alguém leia a frase de transição em voz alta, do slide. Ler a frase em voz alta uma vez na vida acadêmica aumenta muito a chance de ela sair na urgência.

Detalhe operacional que não está na tela: a ordem das perguntas importa. Frequência antes de intenção, intenção antes de plano, plano antes de preparação. Quem começa por plano recebe negativa e encerra a avaliação.

A segunda metade da pergunta sobre preparação, ”mesmo que depois você tenha desistido”, é o que produz a informação mais decisiva da entrevista. Diga isso explicitamente.

Parte 3, como formular

A matriz é o eixo da aula. Vale gastar tempo aqui e economizar na parte 1.

Detalhe que não está na tela: a matriz não é soma, é interação. Um acesso disponível em alguém que colabora plenamente pesa diferente do mesmo acesso em alguém que oculta. Diga essa frase, porque o desenho sugere adição e a clínica não é aditiva.

No frame do semáforo, deixe claro que escalas não são proibidas. Elas ajudam a não esquecer perguntas. O que não se faz é transformar o escore em conduta.

Parte 3B, os quatro contextos

Estes dois frames existem porque os seis casos da atividade não cobrem nenhum destes contextos. Sem eles, o recorte transdiagnóstico é anunciado e não entregue. Não os corte por falta de tempo: corte um frame da parte 1.

Detalhe operacional sobre adolescente: o dever de comunicação ao Conselho Tutelar existe quando há suspeita ou confirmação de violência, o que inclui a violência autoprovocada em menor de idade. A comunicação à família é regra, e a exceção é quando a própria família é a fonte do risco. Nunca prometer sigilo absoluto antes de saber o que será contado.

Detalhe sobre pessoa idosa: a maior taxa de mortalidade por suicídio no Brasil está nos homens com 70 anos ou mais, e é a faixa com mais contato prévio com a atenção primária no mês anterior. Os dois dados juntos são o argumento inteiro.

Parte 4, o que fazer agora

Detalhe operacional que não está na tela, sobre restrição de acesso: quem retira o meio não pode ser o paciente. A conversa é com quem executa, com prazo e com conferência posterior. A pergunta sobre arma de fogo é a primeira, e a mais esquecida.

Sobre o plano de segurança: ele é escrito com o paciente, nas palavras dele, e de preferência no celular dele, com os números já preenchidos. Plano de segurança que fica com o médico não é plano de segurança.

Sobre farmacologia: a aula não entra em dose, porque o assunto é conduta e não prescrição. Se a turma puxar, o encaminhamento é para a preleção de humor do módulo e para o ambulatório. O que a aula sustenta é o princípio, ou seja, segurança em superdosagem e quantidade dispensada entram na decisão como um fator entre outros.

Sobre lítio: não apresentar como resgate. A evidência é de manutenção em transtornos do humor. Alguém vai perguntar se ”dá lítio na crise”. A resposta é não, e o motivo é que o efeito medido é de longo prazo.

Sobre escetamina: no Brasil apenas a apresentação nasal tem indicação aprovada, para depressão resistente e para ideação suicida aguda. A injetável para transtornos mentais é uso off label, com exigências de ambiente, monitorização, prescritor e consentimento. A frase que precisa ficar é que melhora sintomática rápida não equivale a prevenção de comportamento suicida.

Parte 5, ele pode sair daqui?

O frame das oito informações à regulação é para ser lido na ordem, em voz alta, uma vez. Peça que um aluno faça o papel da regulação e outro passe o caso. Custa dois minutos e é o ensaio mais próximo do real que a aula oferece.

Detalhe operacional sobre a tabela de modalidades: o laudo circunstanciado é exigência de toda internação, e não só da involuntária. A comunicação ao Ministério Público em 72 horas cabe ao responsável técnico do estabelecimento, não ao plantonista que indicou, e se repete na alta. A Resolução CFM 2.057/2013 usa a expressão diretor técnico médico para o mesmo papel; use o termo legal na tela e mencione a equivalência aqui.

A compulsória é judicial. Se alguém disser ”aciona a compulsória”, corrija na hora: não é a via da urgência, e confundir involuntária com compulsória é o erro mais previsível da turma.

Sobre contenção: indicação, prescrição, monitorização e registro. Acrescente que a contenção precisa de hora de término escrita, porque contenção sem término no prontuário é contenção indefinida.

Parte 6, o depois

Detalhe operacional sobre notificação: a Lei 13.819/2019 cria a obrigação e não fixa prazo. O prazo de 24 horas vem da Lista Nacional de Notificação Compulsória, onde tentativa de suicídio está entre os agravos de notificação imediata. Ideação isolada, sem tentativa e sem automutilação, não é por si evento notificável. Essa distinção evita tanto a subnotificação quanto a notificação indiscriminada.

Sobre registro: diga que as duas funções são a mesma escrita. Um registro que permite reconstruir a decisão clínica é também o que sustenta a conduta em questionamento. Não se escreve para o processo; escreve-se bem.

Parte 7, síntese

O algoritmo final e a tela de frases são os dois PDFs isolados da entrega. Diga à turma que esses dois são para levar no bolso do jaleco, em tela de celular.

Condução do Tempo 2

Explicação da atividade, 10 minutos

Divida os grupos antes do intervalo, não depois. Projete o frame do produto durante todo o trabalho dos grupos, com o cronômetro ao lado.

Com dez alunos por grupo, o risco é a carona. Peça, ao dar a tarefa, que cada grupo nomeie quem apresenta cada um dos quatro blocos da defesa. Isso distribui o trabalho sem mudar a folha.

Trabalho dos grupos, 40 minutos

Circule pelos seis grupos com uma pergunta só, sempre a mesma: o que, neste paciente, muda o que vocês farão nos próximos 30 minutos? Não corrija formulação durante o trabalho. Se um grupo estiver indo para um erro previsível, deixe: o erro é material da plenária.

Aos 25 minutos, avise em voz alta que faltam 15 e que os campos 6 e 7 costumam ficar em branco. São os dois que mais rendem na plenária.

Defesas, 4 minutos por grupo

Cronometre e corte. Proibido apresentar o caso: a turma leu todos. Se um grupo começar contando a história, interrompa na primeira frase e peça a formulação.

Ordem sugerida das defesas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ordem numérica preserva os pares e facilita a plenária.

Anote, durante as defesas, uma frase de cada grupo para citar depois. A plenária fica muito melhor quando você cita o grupo em vez de descrever o erro no abstrato.

Plenária por pares, 25 minutos

Nunca grupo a grupo. São três blocos de cerca de oito minutos.

Pares 1 e 2. Pergunta: se a frase e o diagnóstico eram os mesmos, o que realmente separou as duas condutas? Conduza até que os três elementos sejam nomeados, que são comportamento preparatório, ocultação e capacidade de colaborar. Revele então, e só então, que idade, sexo, profissão, tempo de doença, medicação, acompanhante e desesperança eram idênticos nos dois dossiês, e que os textos foram escritos para serem indistinguíveis fora desses três pontos. Esse é o momento de maior rendimento da tarde.

Pares 3 e 4. Pergunta: que erro aparece quando o diagnóstico substitui a formulação? No grupo 3 o rótulo de transtorno bipolar faz procurar o deprimido retraído, e o risco está no estado misto. No grupo 4 o rótulo de borderline convida a desqualificar, e o risco está na combinação de cronicidade com um episódio agudo de mobilização.

Pares 5 e 6. Pergunta: o que muda quando o paciente não consegue participar plenamente da própria segurança? No grupo 5 a incapacidade é transitória e a resposta é tempo e reavaliação. No grupo 6 a incapacidade é do próprio quadro e a resposta é ambiente.

Fechamento, 5 minutos

Quatro frases, na ordem. Risco não é etiqueta. A mesma fala não significa o mesmo risco. O mesmo diagnóstico não produz a mesma conduta. Uma boa avaliação termina em decisão de segurança.

Encerre repetindo o CVV 188 e dizendo que você fica na sala mais dez minutos.

O que confirmar antes da aula

- A configuração atual da RAPS em Guarapuava e o nome dos serviços que a turma vai usar no estágio, porque é isso que torna o campo continuidade preenchível.
- A composição e a denominação atuais das modalidades de eMulti, que sucederam o NASF-AB a partir da Portaria GM/MS 635/2023.
- O fluxo local de regulação e de acionamento do SAMU, com o número que a turma deve usar.
- Se há boletim epidemiológico mais recente que o volume 55, número 4, de 2024, com dados posteriores a 2021.

Referências

Norma

Brasil. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Artigos 4, 6, 7, 8 e 9.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.391, de 26 de dezembro de 2002. Regulamenta o controle das internações psiquiátricas involuntárias e voluntárias.

Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.057, de 20 de setembro de 2013. Consolida as diversas resoluções da área da psiquiatria. Artigos 16, 29 e 31.

Brasil. Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019. Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Artigo 6.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.061, de 18 de maio de 2020. Lista Nacional de Notificação Compulsória, item 48.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023. Institui as equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde, eMulti.

Conselho Federal de Medicina. Parecer CFM nº 20/2024. Uso da escetamina solução injetável no tratamento de transtornos mentais.

Epidemiologia

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico, volume 55, número 4, 2024. Panorama dos suicídios e lesões autoprovocadas. Dados do SIM e do SINAN.

Evidência

Cipriani A, Hawton K, Stockton S, Geddes JR. Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013;346:f3646.

Tondo L, Hennen J, Baldessarini RJ. Lower suicide risk with long-term lithium treatment in major affective illness: a meta-analysis. Acta Psychiatr Scand. 2001;104(3):163-72.

Meltzer HY, Alphs L, Green AI, et al. Clozapine treatment for suicidality in schizophrenia: International Suicide Prevention Trial (InterSePT). Arch Gen Psychiatry. 2003;60(1):82-91.

Stanley B, Brown GK, Brenner LA, et al. Comparison of the Safety Planning Intervention with follow-up vs usual care of suicidal patients treated in the emergency department. JAMA Psychiatry. 2018;75(9):894-900.

Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-16.

Dazzi T, Gribble R, Wessely S, Fear NT. Does asking about suicide and related behaviours induce suicidal ideation? What is the evidence? Psychol Med. 2014;44(16):3361-3.

Nota sobre o grau de vinculação

A aula separa três coisas e o handout mantém a separação. O que é norma vem das leis, portarias e resoluções listadas acima e obriga. O que é recomendação apoiada em evidência vem dos estudos listados e orienta, com a força que o desenho de cada estudo permite. O que é interpretação clínica é a leitura do docente sobre como aplicar as duas coisas anteriores em um serviço concreto, e está sujeita a discussão. Quando um aluno perguntar ”isso é obrigatório?”, a pergunta é legítima e a resposta é uma dessas três.